EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 86783
SERVICIO	: MEDICINA HSC		
FECHA	: 2024-06-17 11:33:00		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: INES DEL ROSARIO NAVARRETE ARAYA			**RUN**	: 6.785.741-0
F.Nac	: 30-05-2023	**Edad**	: 1 AÑO	**Género**	: Femenino
Dirección	:			**Comuna**	: SAN NICOLAS
Previsión	: SIN INFORMACION	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-13	**Fecha Egreso**	: 2024-06-17 11:33:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

ITU:
E. coli BLEE
¿Neumonía?
CA recto en CP
Trastorno depresivo leve
Obs Demencia
AP: DMT2, HTA, DHC

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39-OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Femenina De 73 Años Con Antecedentes De Ca De Recto En Cuidados Paliativos , Dm2ir, Hta, Dhc. Tratamiento Farmacológico: - Morfina 2 % 10-12 Gotas Cada 6 Horas (Usuaria Había Estado En Tto Con Morfina Sc,Sin Embargo Paciente Se Desorienta Por Lo Que Se Cambió A Morfina Vía Oral) - Quetiapina 25mg 1 Com En La Noche - Insulina 10 Ui, Cada 12 Hrs - Durogesic 50ug Cada 3 Días.

Derivada Por Desorientacion Y Sintomas Respiratorio Dado Por Tos Y Disnea
Nos Refiere El Familiar Que Hace 4 Dias Con Deposiciones Blandas Se Realiza Exámenes De Laboratorio Proteina C Reactiva : 69,7 Hemoglobina : 11,9 G/Dl Hematocrito : 35,7 O/O Recuento De Leucocitos : 6,30 Mil/Ul Recuento Hematies : 4,40 Mill/Ul Plaquetas : 167, Orina inflamatoria . Al Examen Físico Vigil, Desorientad, Torax Hipoexpansible Disminuido Bilateralmente + Crepitos Bibasales Con Requerimiento De Oxígeno , Pór Lo Que Se Hospitaliza.

Durante estancia en servicio de medicina en buenas condiciones generales, con episodios de desorientación de predominio nocturno y heteroagresividad física y verbal con alteración del contenido del pensamiento.
Posterior a inicio de terapia acorde de ATB ademá de ajuste de terapia PSM iniciando con Haldol VO, en buenas condiciones, más orientada y conectada a medio.

Desde el punto de vista infeccioso, bajo terapia ATB con Ertapenem guiada por UCT positivo para E coli BLEE.

Buena respuesta a terapia ATB. Parámetros inflamatorios bajos sin nueva alza durante estancia.

En vista de ello, se decide continuidad de manejo en domicilio con HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. Derivo HODOM
2. Ertapenem 1gr ev 3/7
3. Omeprazol Cap 20 Mg X Dia
4. Haloperidol 1mg vo c12h
5. Clonazepam 2mg vo día
6. Losartan 50mg vo c12h
7. Paracetamol 1gr vo c8h
8. Durogesic 50mg parche cada 72h
9. Bromuro ipratropio 4puff c8h
10. Paracetamol Comp 500 Mg 2 Comp Cada 8h Sos Fiebre O Dolor
11. Control SU SOS

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO